

En un país que envejece: Análisis de la utilización de servicios de salud en Chile

Informe de avance 2

Elisa Calderón

Amalia Tsukame

Departamento de Sociología, Universidad de Chile

ORCID: 0009-0001-0171-7199 | 0009-0004-3578-1289

Profesor guia:

Santiago de Chile

30 de octubre de 2026

Tabla de contenidos

Presentación 1

1 Introducción 2
1.1 Objeto de estudio 3
1.2 Pregunta de investigación 4
1.3 Objetivo general 4
1.4 Objetivos específicos 4

2 Antecedentes conceptuales 5
2.1 Envejecimiento: transición demográfica y epidemiológica 5
2.2 Curso de vida y desigualdad acumulada 6
2.3 Necesidad, acceso y utilización de servicios de salud 7
2.3.1 Necesidades de salud 8
2.3.2 Acceso a los servicios 8
2.3.3 Utilización de los servicios de salud 9
2.4 Modelo Conductual de Andersen 10
2.5 El sistema de salud chileno como contexto: organización, mecanismos de protección y distribución territorial 12
2.6 Distribución territorial de la oferta 15

3 Antecedentes empíricos 18
3.1 Antecedentes empíricos internacionales 18
3.2 Antecedentes empíricos nacionales 19
3.2.1 Facilitadores individuales: ingreso y previsión de salud 19
3.2.2 Facilitadores contextuales 20
3.2.3 Medicina general y hospitalización 21

3.2.4 Edad y sexo 21

4 Metodología 23

4.1 Datos 23

4.2 Variables 24

4.2.1 Variables dependientes 24

4.2.2 Variables independientes 24

4.2.3 Valores perdidos 26

4.3 Estrategia de análisis 26

5 Resultados descriptivos 28

6 Referencias bibliográficas 32

Presentación

La presente investigación se enmarca en nuestro seminario para optar al grado de Licenciatura en Sociología de la Universidad de Chile. El trabajo fue desarrollado en el Departamento de Sociología y cuenta con la supervisión del profesor guía, Dr. Juan Carlos Castillo Valenzuela.

Palabras clave: Utilización de servicios de salud; Envejecimiento poblacional; Desigualdades en salud; Modelo conductual de Andersen; Análisis multivariado.

1 Introducción

A nivel global, las dinámicas demográficas han experimentado una tendencia hacia el envejecimiento. En este contexto, Chile se ha convertido en uno de los países que ha envejecido más rápido en comparación con otras regiones del mundo (United Nations, 2022), y atraviesa uno de los procesos de envejecimiento más avanzados de América Latina (Huenchuan, 2018). Este cambio se evidencia en los resultados del Censo 2024, donde la población de 65 años y más representa el 14 % de la población nacional, frente al 6,6 % registrado en 1992, y el índice de envejecimiento alcanzó 79 personas de 65 años y más por cada 100 personas menores de 15 años (Instituto Nacional de Estadísticas, 2025b). Este fenómeno también se manifiesta en la propia población mayor: las personas de 80 años y más, que en 1992 representaban el 11 % de la población adulta mayor, alcanzarían un 28 % en el año 2050 según las proyecciones (INE, 2022).

Esta transformación de la estructura por edades plantea desafíos para la organización de los sistemas e instituciones públicas y, en particular, para la planificación de los servicios de salud (Huenchuan, 2011), ya que el aumento de la longevidad y la mayor presencia de personas en edades avanzadas se producen en un contexto epidemiológico en el que han adquirido relevancia las enfermedades crónicas no transmisibles, la multimorbilidad y las limitaciones funcionales (Albala, 2020). Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2023-2024, el 40,1 % de la población de 15 años y más declara dos o más enfermedades diagnosticadas, y la declaración de enfermedades es mayor en las edades avanzadas (Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología, 2025), lo que proyecta un aumento en la demanda de los servicios de salud (Huenchuan, 2011). No obstante, es importante reconocer que las necesidades de salud no se distribuyen de manera homogénea en la población ya que quienes ocupan mejores posiciones sociales tienen menor probabilidad de enfermar y, cuando enferman, cuentan con más recursos para enfrentarlo (Moscoso Cuaresma et al., 2017).

Desde una perspectiva sociológica, esta heterogeneidad puede comprenderse a partir de la teoría de la ventaja y desventaja acumulada, según la cual las desigualdades en ingresos, salud y estatus tienden a divergir con el paso del tiempo (Dannefer, 2003; Ferraro & Shippee, 2009). Desde este enfoque, personas de la misma edad pueden llegar a la vejez con distintas necesidades de salud y con posibilidades desiguales

de acceder a la atención. Además, la magnitud de este proceso no es la misma en todas las sociedades, sino que depende de sus instituciones (Dannefer, 2003).

En Chile, el sistema de salud está segmentado entre un seguro público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y aseguradoras privadas, las Isapres, generando una distribución desigual de los recursos y diferencias en el acceso y calidad de la atención (Bass del Campo, 2025). Esto se acompaña de desigualdades territoriales en donde los médicos especialistas y la infraestructura de mayor complejidad se concentran en la Región Metropolitana y en los principales centros urbanos (Clínicas de Chile, 2025; Superintendencia de Salud, 2023), mientras que en las zonas rurales la atención se basa principalmente en postas de salud que presentan importantes limitaciones estructurales y de atención (MINSAL y Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2025).

El argumento central de esta investigación es que, en un contexto de envejecimiento poblacional, la mayor necesidad de atención no se traduce automáticamente en utilización de servicios de salud: esta también se asocia con los recursos económicos, de cobertura y las condiciones territoriales de las personas, y que pueden variar entre grupos de edad. Frente a este escenario, interesa conocer cómo la utilización de los servicios de salud se distribuye según los recursos económicos, la cobertura y el territorio, y si esa distribución cambia a lo largo de la vida adulta. Para esto, se utilizará el Modelo Conductual de Utilización de Servicios de Salud de Andersen (1995, 2008), que ofrece un marco para examinar estas relaciones al distinguir entre factores predisponentes, de necesidad y facilitadores de la utilización.

Para abordar empíricamente esta problemática, la presente investigación utilizará Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024 y se analizará la utilización declarada de tres tipos de servicio en la población de 18 años y más residente en viviendas particulares en Chile: medicina general, atención de especialidad y hospitalización o intervención quirúrgica. Se estimarán modelos de regresión logística binaria anidados, incorporando progresivamente los distintos grupos de factores de Andersen para examinar su asociación con la utilización de los servicios.

1.1. Objeto de estudio

El objeto de estudio corresponde a la utilización declarada de servicios de salud (atención de medicina general, de especialidad y hospitalización o intervención quirúrgica) en la población adulta residente en viviendas particulares en Chile, y su diferenciación según la edad, el ingreso, la previsión de salud y el territorio de residencia.

1.2. Pregunta de investigación

A partir de lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué factores se asocian con la utilización de servicios de salud en las distintas edades de la población adulta en Chile?

1.3. Objetivo general

Analizar qué factores se asocian con la utilización de servicios de salud en la población adulta de Chile y si esas asociaciones cambian entre grupos de edad.

1.4. Objetivos específicos

1. Describir los patrones de utilización de medicina general, atención de especialidad y hospitalización o intervención quirúrgica según grupo de edad en la población de 18 años y más en Chile.
2. Estimar la asociación del ingreso y la previsión de salud con la utilización de medicina general, atención de especialidad y hospitalización o intervención quirúrgica, considerando ambas variables conjuntamente.
3. Analizar la asociación del territorio de residencia con la utilización de medicina general, atención de especialidad y hospitalización o intervención quirúrgica.
4. Explorar si las asociaciones del ingreso, la previsión y el territorio con la utilización de medicina general, atención de especialidad y hospitalización o intervención quirúrgica varían entre grupos de edad.
5. Explorar si los patrones de utilización y sus asociaciones difieren entre hombres y mujeres.

2 Antecedentes conceptuales

2.1. Envejecimiento: transición demográfica y epidemiológica

El envejecimiento constituye una de las transformaciones sociales más relevantes del siglo XXI (United Nations, 2020) y se configura como un fenómeno multidimensional, que puede abordarse desde perspectivas biológicas, sociales, económicas y culturales.

De manera específica, el envejecimiento admite dos niveles de análisis, relacionados pero conceptualmente distintos. En el plano individual, es un proceso gradual, que ocurre a lo largo de toda la vida y es irreversible (Chackiel, 2000). Por otro lado, en el plano demográfico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s. f.) lo define como el aumento progresivo de la proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la población total, lo que resulta en una progresiva alteración de la estructura por edades. En Chile, la Ley N° 19.828 define como adulta mayor a quien ha cumplido 60 años y adulto mayor de la cuarta edad a quien ha cumplido 80 años (Ley N° 19.828, 2002).

Esta transformación de la estructura etaria se vincula con la transición demográfica, un proceso histórico desarrollado inicialmente en Europa para explicar los cambios demográficos, y que describe el paso de niveles elevados a niveles bajos de natalidad y mortalidad (INE, 2022). Para explicar este proceso, Chesnais (1990, como se citó en Chackiel, 2000) distingue distintas etapas demográficas: el descenso inicial de la mortalidad, con una fecundidad todavía elevada, rejuvenece la población; luego, la caída de la fecundidad reduce el peso relativo de la población infantil; y cuando la fecundidad alcanza niveles muy bajos y las ganancias en sobrevida se concentran en las edades avanzadas, el envejecimiento se intensifica. En la misma línea, la CEPAL clasifica a los países según el nivel de su fecundidad y la proporción de personas mayores en cinco etapas de envejecimiento: incipiente, moderado, moderadamente avanzado, avanzado y muy avanzado (Huenchuan, 2018; Hugo Rojas et al., 2022).

Aunque la transición demográfica ofrece un marco general, su duración y su velocidad varían entre regiones. Mientras que en Europa tomó cerca de dos siglos alcanzar las etapas avanzadas, algunos países

de América Latina y el Caribe las recorrieron en menos de medio siglo (INE, 2022; Hugo Rojas et al., 2022), a una velocidad heterogénea (CEPAL, 2026) que ha superado la capacidad institucional de las sociedades para generar condiciones de desarrollo sostenible y protección social (Turra & Fernandes, 2021). De manera específica, en Chile, la fecundidad se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1) con 1,03 nacidos vivos promedio por mujer para el año 2024 (INE, 2025a), lo que ha reducido la proporción de personas de 14 años o menos desde un 29,4 % en 1992 a un 17,7 % en 2024, mientras que la esperanza de vida supera los 81 años (INE, 2025a). Estos procesos, en su conjunto, ubican al país en la clasificación de envejecimiento avanzado (Huenchuan, 2018). Según las proyecciones del INE, este proceso se profundizará y, para el año 2045, la población de 65 años y más triplicaría a la menor de 15 años (INE, 2026).

En paralelo, junto con el proceso de envejecimiento se ha producido en el país una transición epidemiológica, en la cual se ha experimentado un aumento de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles, tanto crónicas como agudas, siendo las primeras causas de muerte para el año 2023 las enfermedades del sistema circulatorio (31.149), neoplasias (30.796), enfermedades respiratorias (13.728) y causas externas (8.279) (MINSAL, 2023; Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 2026). Albala (2020) señala también que el envejecimiento produce una acumulación de enfermedades crónicas en mayores de 60 años, constituyéndose como un factor que influye en la utilización de los servicios de salud (Travassos & Martins, 2004).

2.2. Curso de vida y desigualdad acumulada

Para analizar las diferencias entre personas de distintas edades, resulta útil el enfoque del curso de vida, que desde finales de 1990 ha adquirido relevancia en la investigación sobre envejecimiento, al permitir examinar cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos y sociales configuran tanto las vidas individuales como las de las cohortes o generaciones (Blanco, 2011; Robledo Marín & Orejuela Gómez, 2021). Su concepto central es el de trayectoria: un recorrido a lo largo de la vida que se despliega en ámbitos interdependientes, como el trabajo, la educación o la familia, y que está marcado por transiciones y puntos de inflexión (Blanco, 2011). Desde esta perspectiva, la vejez no es una etapa aislada, sino el resultado de trayectorias previas, lo que permite preguntarse por qué personas de una misma edad llegan a ella en situaciones muy distintas.

La teoría de la ventaja y desventaja acumulada (CAD) ofrece esa explicación. Dannefer (2003) la define como una “tendencia sistémica a la divergencia interindividual” en características como el dinero, la salud o el estatus a medida que pasa el tiempo (p. S327). Su punto central es que esta divergencia no es

una simple proyección de las posiciones iniciales, sino el resultado de la interacción de múltiples fuerzas, y que es una propiedad de colectividades, como las cohortes, más que de individuos aislados (p. S327). Por eso, las diferencias asociadas a la edad deben leerse como el producto de procesos que se acumulan a lo largo del curso de la vida.

Ferraro & Shippee (2009) desarrollan esta idea en la teoría de la desigualdad acumulada (CI). Su primer planteamiento es que los sistemas sociales generan desigualdad y que esta no es principalmente resultado de decisiones individuales, sino de arreglos estructurales. Su segundo planteamiento es que la desventaja aumenta la exposición a riesgos, mientras que la ventaja aumenta la exposición a oportunidades, de modo que ambas no son simples opuestos en una misma escala. Si bien muchos resumen la CAD con la máxima de que "la ventaja se acumula", los autores insisten en que lo relevante es el proceso por el cual esto ocurre y no solo la brecha final. A su vez, las trayectorias no están determinadas: los recursos disponibles y la acción de las personas pueden atenuar desventajas previas.

Dannefer (2003) sostiene que el envejecimiento de cada cohorte implica la reproducción de desigualdades en salud, con prácticas de salud diferenciadas y acceso estratificado a la atención (p. S331). Señala también que dimensiones institucionales, independientes de las características individuales de las personas, inciden en factores como los ingresos, la estabilidad laboral y el acceso a la salud (p. S332). A esto se suma que la intensidad de la CAD varía entre sociedades según sus políticas económicas y de bienestar (p. S328). Esta idea se puede visualizar para el caso chileno: un sistema de salud segmentado entre Fonasa e Isapres funciona como una estructura que distribuye de manera diferenciada las oportunidades de acceso y utilización (Bass del Campo, 2025), de modo que las ventajas y desventajas acumuladas previamente se traducen en formas distintas de relacionarse con el sistema en la vejez.

Es importante precisar que el diseño transversal de esta investigación no permite observar directamente la acumulación en el tiempo, sino solo sus huellas en un momento dado. Ferraro & Shippee (2009) advierten que estudiar únicamente a personas de edades avanzadas implica trabajar con una población ya "truncada" por la mortalidad, lo que puede dar la falsa impresión de que la desigualdad disminuye en la vejez. Dannefer (2003) también cuestiona la inferencia de trayectorias a partir de comparaciones transversales entre edades (p. S328-S329). Por eso, ambas aproximaciones se utilizan aquí como marco interpretativo y no como hipótesis que se pretenda contrastar de forma directa.

2.3. Necesidad, acceso y utilización de servicios de salud

Para comprender cómo se vinculan las diferencias por edad y las condiciones sociales con el sistema sanitario, es necesario distinguir entre tres conceptos que están relacionados pero que no son equivalen-

tes: necesidades de salud, acceso a la atención y utilización de los servicios de salud. La relevancia de distinguirlos radica en que las necesidades de salud no se traducen necesariamente en una demanda de atención y, aun cuando las personas requieran asistencia sanitaria, su utilización puede depender tanto de sus características individuales y sociales como de las condiciones en que se organiza la oferta de servicios.

2.3.1. Necesidades de salud

Asadi-Lari et al. (2003) señalan que la necesidad de salud es un concepto cuya definición tiene implicaciones directas en la formulación de políticas y en la organización de los servicios, ya que una conceptualización restrictiva puede limitar el reconocimiento de las necesidades de la población y el alcance de las respuestas destinadas a satisfacerlas. Desde un enfoque económico tradicional, la necesidad se define a partir de la capacidad de beneficiarse de una intervención médica, vinculándola con su efectividad. Sin embargo, este enfoque puede resultar acotado, ya que se concentra en los beneficios de la atención y puede dejar de lado dimensiones personales y sociales relevantes para la salud (Asadi-Lari et al., 2003).

Desde una perspectiva sociológica, Bradshaw (1972, como se citó en Asadi-Lari et al., 2003) distingue cuatro tipos de necesidades: las necesidades normativas, las cuales son identificadas a partir de criterios profesionales; las necesidades sentidas que corresponden a lo percibido o experimentado por las personas; las necesidades expresadas, que son aquellas que se verbalizan o se traducen en un uso de los servicios de salud; y, por último, las necesidades comparativas identificadas al contrastar las condiciones de grupos con características similares que viven en contextos diferentes.

En una línea similar, Andersen (1995, 2008) plantea una distinción cercana entre necesidad percibida y necesidad evaluada, permitiendo distinguir entre la existencia de una necesidad, su reconocimiento por parte de las personas y su manifestación mediante una demanda de atención. Sin embargo, una necesidad identificada a partir de criterios profesionales no necesariamente será percibida o expresada por quien la experimenta, y la ausencia de utilización no permite concluir, por sí sola, que no exista una necesidad.

2.3.2. Acceso a los servicios

El acceso a los servicios de salud constituye otra dimensión relevante para comprender la relación entre las necesidades de atención y la utilización efectiva de los servicios. Su conceptualización también ha presentado dificultades, tanto por la amplitud del fenómeno como por la diversidad de criterios utilizados para definirlo y medirlo.

Una primera línea lo entiende como resultado de la interacción entre factores de oferta y de demanda. Rodriguez Santana et al. (2023) definen el acceso como la obtención de la atención sanitaria correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto, reconociendo que el acceso no se limita a la disponibilidad de servicios ni a su utilización efectiva, sino que también considera si la atención recibida responde apropiadamente a las necesidades de salud. Una segunda línea lo concibe como una relación de ajuste. Penchansky & Thomas (1981) conceptualizan el acceso como el grado de ajuste entre los usuarios potenciales y los recursos sanitarios, influido por las características de quienes prestan los servicios y de quienes los requieren. Esta perspectiva permite reconocer que el acceso no depende exclusivamente de la existencia física de establecimientos de salud, sino del vínculo entre las condiciones de vida de la población y las barreras institucionales, económicas o geográficas de la red asistencial. Una tercera línea, más integradora, entiende el acceso como un proceso que comprende las oportunidades de identificar las necesidades de salud, buscar atención, llegar a los servicios, obtener atención y beneficiarse de ella (Levesque et al., 2013). De esta manera, el acceso puede verse condicionado por barreras que surgen en distintas etapas, incluso cuando existen servicios disponibles.

Finalmente, Aday & Andersen (1974) señalan que este concepto ha sido más una idea política que operativa y abordan esta problemática mediante un marco orientado a examinar la relación entre las características de la población, las condiciones del sistema sanitario y la utilización de la atención. Desde esta perspectiva, el acceso no se limita a la existencia de servicios, sino que comprende las condiciones que influyen en la posibilidad de obtener atención sanitaria. En las primeras versiones del modelo de Andersen, el acceso se entendía como el ingreso a los servicios y la atención posterior; luego se amplió hacia un concepto multidimensional, compuesto por el acceso potencial y el acceso realizado (Travassos & Martins, 2004).

2.3.3. Utilización de los servicios de salud

La utilización de los servicios de salud también presenta múltiples definiciones, y los primeros intentos de desarrollar modelos teóricos al respecto se remontan a las décadas de 1950 y 1960, pasando por el modelo de creencias en salud, hasta llegar al modelo de Andersen (Travassos & Martins, 2004).

Según Travassos & Martins (2004), el núcleo del funcionamiento de los sistemas de salud corresponde a la utilización de los servicios, y comprende las distintas formas en que las personas usan las prestaciones sanitarias, incluidas las consultas médicas, las hospitalizaciones y la realización de exámenes preventivos y diagnósticos.

Desde el modelo de Andersen (2008), la utilización de los servicios de salud se define como el acceso realizado o efectivo, el cual está determinado conjuntamente por las características de la población y por las propiedades del sistema de salud. En esta misma línea, Levesque et al. (2013) señalan que en la investigación empírica la utilización suele emplearse como el principal indicador operativo del acceso, dado que el uso efectivo es directamente observable y medible, a diferencia del acceso potencial.

En una escala poblacional, la utilización de los servicios de salud también se ha empleado como un indicador indirecto de las necesidades de atención. Sin embargo, esta aproximación presenta limitaciones, puesto que el uso observado no refleja necesariamente la totalidad de las necesidades existentes en una población. De manera concreta, los registros del uso de los establecimientos también están condicionados por la disponibilidad de servicios, las decisiones clínicas y las alternativas de atención existentes, por lo que no pueden interpretarse como una medida directa de las necesidades de salud (Asadi-Lari et al., 2003).

Con todo lo anterior, la utilización está moldeada simultáneamente por la oferta, la demanda y los recursos individuales, por lo que su análisis requiere controlar por los distintos factores que median entre tener una necesidad de salud y lograr atención médica efectiva. Es por esto que no permite captar por sí sola todas las dimensiones del acceso a la atención y tampoco permite afirmar que las necesidades fueron realmente cubiertas al momento de utilizar el sistema de salud.

2.4. Modelo Conductual de Andersen

Para analizar los factores asociados a la utilización de servicios sanitarios, esta investigación adopta como marco teórico el Modelo Conductual de Utilización de los Servicios de Salud, desarrollado inicialmente por Ronald Andersen en 1968 y posteriormente revisado y ampliado (Andersen, 1995, 2008). El modelo surgió con el propósito de comprender por qué las personas y familias utilizan los servicios médicos, establecer criterios operativos para medir el acceso equitativo a la atención y contribuir al diseño de políticas orientadas a promover dicho acceso (Andersen, 2008).

En su formulación clásica, el modelo plantea que el uso de servicios depende de la predisposición de las personas a utilizarlos, de los factores que facilitan o dificultan ese uso y de su necesidad de atención (Andersen, 2008). A partir de ello distingue tres grupos de factores.

En primer lugar, los factores predisponentes, los que corresponden a características individuales y sociales que anteceden a la utilización y estructuran la propensión a utilizar servicios, como son las ca-

racterísticas demográficas, la estructura social y las creencias relacionadas con la salud. Por sí solos no determinan el uso, pero definen la inclinación de las personas a buscar atención.

En segundo lugar, los factores facilitadores, los cuales representan recursos y condiciones que pueden permitir o dificultar la utilización, como los recursos económicos, la cobertura de salud y la disponibilidad de medios para acceder a la atención. Son relevantes porque representan la dimensión del acceso que puede ser modificada mediante políticas y por la organización del sistema.

Por último, los factores de necesidad, los cuales representan las condiciones que hacen necesaria o potencialmente necesaria la utilización de servicios. Andersen distingue entre la necesidad percibida por las propias personas y la necesidad evaluada según criterios profesionales, distinción cercana a la que plantea Bradshaw entre necesidades sentidas y normativas.

Estos tres grupos no operan al mismo nivel. En el modelo, los factores predisponentes anteceden a los demás, los facilitadores habilitan o restringen que la predisposición se concrete en uso, y la necesidad constituye el determinante más próximo de la utilización (Travassos & Martins, 2004). Para esta investigación, esto implica que la edad, al ser una característica predisponente, puede relacionarse con la utilización tanto por las necesidades de salud que acompañan al envejecimiento como por características individuales y sociales.

A su vez, esta articulación refleja el desarrollo conceptual del modelo. En tanto, las primeras versiones explicaban la utilización principalmente a partir de características individuales, las versiones posteriores incorporan el sistema de salud, el contexto social, la interacción entre estos factores y la experiencia previa en el uso de servicios, de modo que la utilización pasa a entenderse como el resultado conjunto de factores individuales y contextuales (Andersen, 2008; Travassos & Martins, 2004).

Andersen (2008) señala que estas características se miden a nivel agregado e incluyen aspectos relacionados con la comunidad, la organización del sistema sanitario y los prestadores de servicios. De este modo, los factores predisponentes, facilitadores y de necesidad pueden examinarse tanto en el plano individual como en el contextual. A nivel poblacional se pueden considerar, por ejemplo, características sociodemográficas de la comunidad, disponibilidad de personal e infraestructura sanitaria e indicadores de morbilidad, mortalidad y discapacidad. Esta ampliación permite incorporar al análisis las condiciones del entorno en el que las personas desarrollan sus necesidades y buscan atención, y en particular el rol de la oferta sanitaria en los territorios.

El modelo se vincula también con la evaluación de la equidad en el acceso. Andersen (2008) refiere que la equidad es subjetiva, pero tradicionalmente se ha definido el acceso equitativo como aquel que se produce cuando las variables demográficas y de necesidad explican la mayor parte de la varianza en

la utilización, mientras que el acceso inequitativo se produce cuando la estructura social, las creencias sobre la salud y los recursos facilitadores determinan quién recibe atención médica. En este estudio, esta distinción se utiliza como criterio de interpretación, en la cual, una utilización que varía según factores distintos de la necesidad se entenderá como indicio de inequidad en el acceso, y no como un efecto causal.

En este sentido, la relevancia del modelo para el estudio del envejecimiento radica en que históricamente se ha vinculado al análisis de encuestas nacionales sobre utilización sanitaria, condiciones socioeconómicas y estado de salud (Andersen, 2008), lo que lo hace compatible con el estudio de fenómenos poblacionales. En definitiva, este modelo proporciona una estructura analítica para estudiar la utilización de consultas generales, de especialidad y hospitalizaciones no solo como respuesta a una necesidad individual asociada a la edad, sino como un fenómeno condicionado por los recursos disponibles y el contexto socio-sanitario en el que envejecen las personas.

2.5. El sistema de salud chileno como contexto: organización, mecanismos de protección y distribución territorial

Las instituciones constituyen mecanismos mediante los cuales se canalizan las demandas de los grupos vulnerables y se sostiene la cooperación colectiva (Huenchuan, 2016). El sistema de salud es la institución central para responder a las necesidades sanitarias de la población, pero como se mencionó anteriormente, la forma en que organizan y distribuyen sus recursos puede facilitar o restringir el acceso de distintos grupos sociales.

En el caso de Chile, el sistema de salud se caracteriza por ser un modelo mixto que abarca tanto el financiamiento y aseguramiento como la provisión de los servicios médicos, integrando al sector público y privado (Superintendencia de Salud, s. f.-a). Esta estructura dual busca garantizar la cobertura de toda la población mediante diversos mecanismos regulados y fiscalizados por el Estado, el cual delega la administración del sistema en distintas entidades (González et al., 2019, p. 16). De esta manera, la rectoría recae en el Ministerio de Salud, cuya función es formular y controlar las políticas de salud pública a nivel nacional (MINSAL, s. f.). Por su parte, la Superintendencia de Salud es un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de fiscalizar a Fonasa, a las Isapres y a los prestadores de salud, y está compuesto por dos intendencias: la de Fondos y Seguros Previsionales de Salud y la de Prestadores (González et al., 2019, p. 41). Sin embargo, tanto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como el Ministerio de Salud identifican como principales deficiencias del sistema su

fragmentación administrativa y organizacional, que se expresa en un financiamiento desarticulado y en una provisión desigual de recursos (Goldstein, 2018).

El financiamiento de este sistema se sustenta en la obligación legal de todo trabajador, dependiente e independiente, de cotizar un 7 % de su renta imponible, permitiéndole al usuario elegir dónde destinar estos fondos (Superintendencia de Salud, s. f.-a). El gran pilar estatal es Fonasa, un seguro público financiado por estas cotizaciones y aportes fiscales (González et al., 2019). Sus afiliados se dividen en cuatro tramos (A, B, C y D) según sus ingresos; sin embargo, todos ellos cuentan con atención gratuita (Copago Cero) al atenderse en la red pública bajo la Modalidad de Atención Institucional (Superintendencia de Salud, s. f.-a). Además, los usuarios de los tramos B, C y D pueden optar por la Modalidad Libre Elección para comprar bonos y atenderse en clínicas privadas en convenio (Superintendencia de Salud, s. f.-a).

Por otro lado, se encuentran las Isapres, que administran las cotizaciones obligatorias, pudiendo también captar cotizaciones adicionales o voluntarias (González et al., 2019, p. 42). Estas entidades ofrecen contratos bajo lógicas de mercado (estrictamente reguladas) que se financian con el 7 % legal más una cotización adicional voluntaria si el plan lo requiere (González et al., 2019, p. 82). De forma paralela a estos dos grandes ejes, existe un subsistema cerrado operado por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), para las Fuerzas Armadas, y por la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA), a la que adscriben Carabineros, Gendarmería y la PDI (González et al., 2019).

En cuanto a la provisión de los servicios, la atención médica se articula a través de dos grandes redes. La red pública es administrada por el Estado mediante el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) y sus 29 divisiones territoriales, que disponen de una red asistencial, constituida por hospitales e institutos de especialidad (González et al., 2019, p. 45). A su vez la atención sanitaria se organiza en tres niveles según la complejidad y la cobertura de los problemas de salud que resuelven: primario, secundario y terciario (Vignolo et al., 2011).

La atención primaria de salud (APS) es la puerta de entrada al sistema, tiene una complejidad básica y una amplia cobertura, con atención ambulatoria. Desarrolla un enfoque preventivo, promocional y familiar; sus establecimientos están mayoritariamente bajo administración municipal y su alcance es territorial y comunitario (Gattini, 2018; Olguín, 2025). Está constituida por Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Postas Rurales (PR), Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y Servicios de Atención de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) (Servicio de Salud Metropolitano Sur, s. f.).

El nivel secundario cuenta con una complejidad intermedia y una menor cobertura, y requiere equipos interdisciplinarios (Olguín, 2025). Sus establecimientos son los Centros de Referencia de Salud (CRS) y los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) (SSMS, s. f.).

Por último, el nivel terciario presenta una mayor complejidad, pero una cobertura reducida de la población. Está constituido por los establecimientos hospitalarios (SSMS, s. f.), que pueden recibir pacientes de su propia área de red asistencial o tener un carácter regional o suprarregional, y cuenta con recursos humanos de alta especialización y con recursos materiales y de infraestructura de mayor complejidad técnica (Gattini, 2018).

Como contraparte, la red privada está conformada por clínicas, centros médicos, laboratorios y consultas particulares que absorben principalmente a los afiliados de Isapres, así como a los pacientes de Fonasa que utilizan la libre elección o que son derivados mediante licitaciones del Estado (Equipo EUNAMed, 2025).

Más allá de la segmentación entre redes y seguros, el sistema contempla protecciones que se aplican a todas las personas. Según la Superintendencia de Salud (s. f.-b), independientemente de si la persona está afiliada a Fonasa o a una Isapre, existen garantías universales transversales, entre las que se destaca el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), que asegura por ley el acceso, la oportunidad de atención, la calidad y la protección financiera (con topes máximos de pago) para 90 problemas de salud de alto impacto. Sin embargo, estas garantías cubren un conjunto acotado de problemas de salud, y la evidencia previa indica que la implementación del régimen del Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), luego denominado GES, aumentó la utilización general sin eliminar las desigualdades socioeconómicas (Núñez & Chi, 2013). Asimismo, la Ley de Urgencia establece que, ante una emergencia de riesgo vital o riesgo de secuela funcional grave, el paciente debe ser atendido en el centro de salud más cercano, sea público o privado, sin que se le pueda exigir un cheque en garantía o pago previo; esto no implica que la atención sea gratuita, ya que los costos se pagan posteriormente a través del seguro correspondiente. Una vez estabilizado, el usuario es derivado a la red que corresponda según su seguro (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, s. f.).

Finalmente, el contexto regulatorio del sistema se ha visto profundamente modificado tras la entrada en vigencia de la Ley Corta de Isapres (Ley N° 21.674) en 2024. Esta normativa fue promulgada para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema, que ordenó aplicar una Tabla Única de Factores (TUF) sin discriminación por sexo o edad, y para evitar una quiebra sistémica del sector privado. En ese marco, estableció la devolución gradual de los cobros en exceso realizados desde el año 2020. Además, impuso un ajuste de los planes al 7 % legal, reduciendo los excedentes al exigir mayores beneficios cuando el costo original era inferior a ese mínimo (Goldstein, 2024).

2.6. Distribución territorial de la oferta

En el marco del análisis de los sistemas de salud es necesario comprender cómo las características geográficas condicionan el acceso a la atención médica, y para esto resulta fundamental precisar qué se entiende por oferta sanitaria y sus implicancias.

Rodriguez Santana et al. (2023) definen operativamente la oferta como los servicios e intervenciones preventivas y curativas proporcionadas formalmente por el sistema sanitario, excluyendo de su alcance el cuidado informal y la asistencia social comunitaria. A partir de esta delimitación, el análisis de la oferta no se reduce únicamente al número de establecimientos existentes, sino a la capacidad instalada del sistema, comprendiendo infraestructura, camas, tecnología y la dotación formal de recursos humanos médicos y de especialidad para responder a las necesidades de la población en un contexto geográfico determinado. Esta capacidad instalada se distribuye físicamente sobre un territorio, el cual constituye el espacio concreto donde las personas acceden a los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades, ejercer sus derechos sociales y desarrollar sus proyectos de vida (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018).

En este marco, la disponibilidad de profesionales de la salud, y en particular de especialistas, es una de las principales brechas regionales percibidas por la población (PNUD, 2018). A nivel nacional, Chile registra 3,3 médicos por 1.000 habitantes en 2023, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 3,7 (Banco Mundial, s. f.-b; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2025). De acuerdo con la Superintendencia de Salud (2023), el 39,2 % de los médicos tenía en 2022 un vínculo, no necesariamente exclusivo, con el sector público; es decir, alrededor del 60 % no mantenía vínculo con él, y se accede a ellos por vías distintas a la red pública (Clínicas de Chile, 2025).

Para el año 2024, el 67,3 % de los médicos en Chile tienen alguna especialidad, del total, 37,6 % pertenece al sector público y el 62,4 % al sector privado. La tasa de médicos especialistas es de 1,73 por 1.000 habitantes, ocupando el quinto lugar en la OCDE (Clínicas de Chile, 2025). En relación con su distribución territorial, la Superintendencia de Salud (2023) muestra diferencias marcadas: la Región Metropolitana registra una tasa de 2,46 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes, seguida por Biobío (1,72) y Valparaíso (1,43), mientras que Tarapacá y Arica y Parinacota presentan tasas de 0,70 y 0,81, respectivamente, siendo alrededor de un tercio de la Región Metropolitana. Estas diferencias muestran que la disponibilidad territorial de especialistas es heterogénea y está asociada con factores demográficos y con la capacidad formadora de las instituciones presentes en aquellas regiones (Huaiquilaf-Jorquera et al., 2026).

En relación con los establecimientos hospitalarios, para el año 2024 el 62,6 % son establecimientos públicos (SNSS y FFAA), 37,4 % son prestadores privados (Clínicas de Chile, 2025). La disponibilidad de camas a nivel nacional es de 1,9 por cada 1.000 habitantes para el año 2023 (Banco Mundial, s. f.-a). En el sector privado para el año 2024, la oferta se encuentra fuertemente centralizada ya que el 64,3 % de las camas están en la Región Metropolitana, el 19,9 % en la zona sur, y el 15,8 % restante se encuentra en la zona norte (Clínicas de Chile, 2025). Esta pronunciada concentración geográfica e institucional de la infraestructura de alta complejidad configura un acceso dispar a la cama de un hospital debido a su localización (Fuenzalida et al., 2023), lo que puede restringir la utilización de servicios hospitalarios y de especialidad.

En las zonas rurales, la oferta sanitaria enfrenta limitaciones adicionales. Si bien la ruralidad es variada y en Chile coexisten distintos criterios para definirla (modificando la magnitud de la población rural), estos territorios comparten el aislamiento, la dispersión de la población y una mayor incidencia de pobreza multidimensional, que en 2022 alcanzó un 27,96 % frente a un 15,54 % en las zonas urbanas, además de un envejecimiento de su población (MINSAL y OPS, 2025).

Para responder a esta realidad territorial, la oferta formal del nivel primario se apoya sobre las Postas de Salud Rural (PSR), presentes en el 78 % de las comunas del país, de las cuales el 63 % de estas comunas están clasificadas como rurales. Estos establecimientos constituyen el primer punto de contacto con las comunidades rurales (MINSAL y OPS, 2025). Sin embargo, la capacidad real de esta oferta sanitaria rural presenta limitaciones estructurales dado que un 44 % de las PSR a nivel nacional posee una antigüedad igual o superior a 30 años y un 14 % no cuenta con box de procedimientos. Asimismo, la comunicación de estos establecimientos es limitada: el 70 % de las PSR no cuenta con teléfono fijo y el 89 % carece de teléfono satelital (MINSAL y OPS, 2025).

Según el modelo de Andersen (2008), estas características pueden entenderse como factores facilitadores contextuales que dificultan el uso de servicios. Dado que la oferta sanitaria rural es limitada y la distancia a los centros urbanos implica barreras de entrada a la atención, se hace necesario trasladarse para acceder a otros niveles de atención, lo que supone un gasto de bolsillo (MINSAL y OPS, 2025). Estas desigualdades territoriales adquieren relevancia para abordar la distribución desigual de los recursos asociado al modelo de administración actual y fortalecer la capacidad resolutiva del nivel primario de atención en salud (Goldstein, 2018).

En síntesis, la distribución de la oferta sanitaria en Chile no es equilibrada: la concentración de especialistas y de camas, junto con las limitaciones de la red rural, sugiere que el lugar de residencia puede modificar las posibilidades de utilizar servicios de especialidad y hospitalarios, más allá de la necesidad de atención de cada persona. Asimismo, es relevante considerar que la oferta de servicios no es lo mismo

que el acceso ni que la utilización: que existan especialistas o camas en un territorio no asegura que todas las personas puedan llegar a ellos, ni que quienes llegan los utilicen. Por eso, en esta investigación, la oferta se entiende como una condición del contexto que puede facilitar o restringir la utilización, y no como una medida de esta.

3 Antecedentes empíricos

3.1. Antecedentes empíricos internacionales

La literatura internacional ha documentado la relación entre el estatus socioeconómico y el uso de servicios de salud. En una revisión de carácter comparado, Lantz (2001) señala que, si bien la disponibilidad y la utilización de la atención de salud dependen de múltiples factores, los indicadores de estatus socioeconómico (ESE), como el ingreso, el nivel educacional y la condición ocupacional, se asocian significativamente con la utilización de servicios en distintos países. Esta relación abarca tanto la cobertura de seguro como el uso de servicios personales: consultas de atención primaria y de especialidad, hospitalizaciones, atención dental y oftalmológica, salud mental, medicamentos con receta y atención domiciliaria (Lantz, 2001).

Con algunas excepciones, la revisión concluye que la mayor parte de los hallazgos empíricos apunta a una asociación positiva: a mayor ESE, mayor utilización de atención de salud, y menores niveles de enfermedad sin tratar y de necesidades médicas insatisfechas. Este patrón se ha observado tanto en hombres como en mujeres, y tanto en población infantil como adulta (Lantz, 2001). En esa línea, los estratos económicos y educativos más bajos tienden a realizar menos consultas, tanto de atención primaria como de especialidad, a utilizar menos los servicios de salud mental, dental, oftalmológica y preventiva, a contar con menos frecuencia con una fuente habitual de atención y a presentar tasas significativamente mayores de necesidades de salud no cubiertas. En algunos análisis, un ESE más bajo se asocia con un mayor uso de servicios médicos y hospitalarios, especialmente por causas evitables; sin embargo, este patrón parece explicarse principalmente por la mayor prevalencia de mal estado de salud en las poblaciones desfavorecidas (Lantz, 2001).

Respecto de los factores demográficos, la revisión encuentra que las edades extremas y el sexo femenino utilizan más los servicios de salud, efecto que está mediado, al menos en parte, por una mayor necesidad de atención. El tamaño y la estructura familiar también se asocian a la utilización, pero la dirección del efecto depende del país: por ejemplo, en sistemas de acceso universal, los hijos de madres solteras

consultan más, mientras que en sistemas con mayores barreras de acceso, este mismo grupo consulta en menor proporción, lo que evidencia la desigualdad (Mendoza-Sassi & Béria, 2001).

El tipo de sistema de salud también modula el efecto del nivel socioeconómico. En países con acceso universal, como Inglaterra o Canadá, las personas de clase baja presentan mejor acceso a los servicios, de modo que el sistema opera como un modificador de efecto que promueve la equidad. En otros contextos, en cambio, los sistemas no logran reducir las desigualdades (Mendoza-Sassi & Béria, 2001).

Por último, entre los factores propios de los servicios de salud, la menor distancia al establecimiento y el mayor número de médicos por habitante aumentan la utilización. En países con una red de servicios adecuada estos factores pierden relevancia, aunque la distancia geográfica puede volver a ser una barrera para grupos específicos, como las personas mayores o quienes tienen alguna limitación funcional (Mendoza-Sassi & Béria, 2001).

3.2. Antecedentes empíricos nacionales

La investigación nacional ha documentado desigualdades en la utilización de servicios de salud en Chile, incluso considerando las diferencias en las necesidades sanitarias de la población. Sin embargo, estas desigualdades no se expresan de igual manera entre los tipos de utilización.

3.2.1. Facilitadores individuales: ingreso y previsión de salud

En relación a las desigualdades socioeconómicas en la utilización de servicios de salud, Núñez & Chi (2013) analizaron la utilización y la equidad en el acceso mediante datos de las encuestas CASEN de 1992 a 2009 y de la Encuesta de Satisfacción y Gasto de Bolsillo en Salud de 2006. Sus resultados muestran que, tras ajustar por necesidad, el 20 % de mayores ingresos utilizaba servicios médicos casi el doble que el 20 % de menores ingresos. En particular, el quintil más pobre registraba una utilización un 7,3 % inferior a la esperada según sus necesidades, mientras que en el quintil más rico era un 10,8 % superior a lo esperado.

En la misma línea y específicamente en las consultas de especialidad, Vásquez et al. (2013), con las encuestas CASEN de 2000, 2003 y 2009, consideraron variables como la salud autoevaluada, las limitaciones físicas, la edad y el sexo para distinguir las diferencias de utilización de aquellas asociadas a necesidades sanitarias. Encontraron que las consultas de especialidad presentaban una distribución favorable a los grupos de mayores ingresos, incluso después de ajustar por necesidad, y que la educación y otros factores socioeconómicos contribuyeron a explicar estas desigualdades (pp. 102–103). Paraje &

Vásquez (2012), con la CASEN 2003 y 2009, también observaron que en ambos años las consultas de especialidad se concentraron en los grupos de mayores ingresos. Por último, Chovar Vera et al. (2014) encontraron que las consultas de especialidad favorecieron a los grupos de mayores ingresos. En función de lo anterior, se plantea que:

H1. A mayor ingreso, mayor probabilidad de consulta de especialidad.

En cuanto a la previsión de salud, Henríquez & Velasco (2015) con datos de la CASEN 1992, 2000 y 2013, estimaron que una mayor probabilidad de afiliación a Isapre se asociaba con una mayor probabilidad de consulta de especialidad y de hospitalización. Asimismo, Vásquez et al. (2013) señalan que la afiliación a una Isapre, junto con el nivel educacional, contribuyó a explicar las desigualdades en la atención de especialidad (pp. 102–103). Esto es coherente con un sistema segmentado que distribuye de manera diferenciada las oportunidades de acceso (Bass del Campo, 2025). Por lo tanto, a partir de esto se plantea:

H2. Estar afiliado a Isapre se asocia con mayor probabilidad de consulta de especialidad y de hospitalización o intervención quirúrgica que estar afiliado a Fonasa.

3.2.2. Facilitadores contextuales

En Chile, la literatura sobre ruralidad se centra en las diferencias de acceso, distancia y distribución de los establecimientos de salud. Según los datos de la CASEN 2022, el 36 % de los hogares rurales con personas mayores se encuentra a menos de 2,5 km de un centro de salud, frente al 88,9 % de los hogares urbanos (Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, 2023). Si bien, estos resultados señalan personas con edades avanzadas, ilustran diferencias territoriales en la proximidad de los servicios. A esto se suma la variabilidad geográfica del país, por ejemplo, en la macrozona norte llegar a centros de salud primaria puede tomar entre 57 y 224,3 minutos y para llegar al hospital o clínica más cercana toma entre 92,9 y 484,9 minutos (Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, 2023). En este contexto, la desigual distribución de la infraestructura hospitalaria afecta la posibilidad de acceder a atención en salud, especialmente lejos de la zona central del país (Fuenzalida et al., 2023).

Respecto del uso efectivo de los servicios de salud, la evidencia es menos concluyente. Paraje & Vásquez (2012) identificaron que, en 2009, el promedio de consultas de especialidad en zonas rurales fue menos de la mitad del observado en zonas urbanas (0,107 frente a 0,237), mientras que la brecha en medicina general fue menor (0,210 frente a 0,265) (pp. 12–13, tabla 5). En cambio, Henríquez & Velasco (2015) estimaron que la zona rural no afectaba la probabilidad de consulta general en 1992 y 2000, pero sí en 2013, mientras que en especialidad y urgencia el efecto existía en los años anteriores y desapareció en

2013. Por su parte, con datos de la CASEN 2017, el Proyecto NODO (2021) informó que el 91,7 % de las personas mayores rurales que reportaron un problema de salud en los últimos tres meses recibió atención médica, frente al 93,3 % de las urbanas, diferencia que no resultó estadísticamente significativa.

Por tanto, aunque la evidencia confirma la relevancia de las barreras territoriales, sus asociaciones con la utilización varían según el servicio y el período estudiado. Por esto, la diferencia observada en las consultas de especialidad resulta especialmente relevante ya que la oferta de especialistas tiende a concentrarse en los centros urbanos. Sobre esta base se plantea que:

H3. Residir en zona rural o lejos de un centro de salud se asocia con menor probabilidad de consulta de especialidad.

3.2.3. Medicina general y hospitalización

A diferencia de lo observado en las consultas de especialidad, los resultados sobre medicina general y hospitalización son menos consistentes. Vásquez et al. (2013) observaron que los resultados variaban según la medida de utilización: a igual necesidad, los grupos de menores ingresos concentraban más días de hospitalización, aunque la probabilidad de hospitalizarse mostraba una distribución ligeramente favorable a los grupos de mayores ingresos (p. 103, tabla 4). Paraje & Vásquez (2012) encontraron que la hospitalización presentó una distribución favorable a los grupos de menores ingresos, y que la medicina general pasó de una distribución ligeramente favorable a ellos en 2003 a otra favorable a los de mayores ingresos en 2009 (p. 13, tabla 6). Por su parte, Henríquez & Velasco (2015) no encontraron una diferencia significativa en la hospitalización entre los mayores de 66 años y el tramo de 15 a 25 años (p. 17). Esto es coherente con la revisión internacional, donde el mayor uso hospitalario de los grupos desfavorecidos se explica principalmente por su peor estado de salud.Como la evidencia no permite anticipar una dirección clara, se exploran:

P1. Se explora si la edad y el ingreso se asocian con la hospitalización o intervención quirúrgica.

P2. Se explora si el territorio se asocia con la medicina general y la hospitalización de forma distinta a como lo hace con la especialidad.

3.2.4. Edad y sexo

En relación con la edad, Chovar Vera et al. (2014) analizaron la utilización de servicios médicos con las encuestas CASEN de 2000, 2003, 2009 y 2011, distinguiendo cuatro grupos etarios, sin embargo, en medicina general y días de hospitalización no se identificó un patrón consistente entre grupos etarios.

Por su parte, Henríquez & Velasco (2015) estimaron que, en los mayores de 66 años, la probabilidad de consulta general y de especialidad fue mayor que en el tramo de 15 a 25 años.

Estos antecedentes muestran que la utilización y su desigualdad varían con la edad, pero no permiten saber si las asociaciones del ingreso, la previsión y el territorio cambian a lo largo de la vida adulta. Desde la ventaja y desventaja acumulada cabría esperar que las diferencias sean mayores en edades avanzadas, porque han tenido más tiempo para acumularse. Sin embargo, estudiar a la población adulta mayor puede subestimar la desigualdad ya que la mortalidad actúa como filtro selectivo en grupos más vulnerables (Ferraro & Shippee, 2009). La evidencia internacional sugiere, además, que la distancia a los servicios puede ser una barrera particular para las personas mayores o con limitación funcional (Mendoza-Sassi & Béria, 2001). Como el diseño transversal no permite distinguir entre estas lecturas, se exploran:

P3. Se explora si la asociación entre el ingreso y la utilización de cada tipo de atención cambia según el grupo de edad.

P4. Se explora si la asociación entre el territorio y la utilización de cada tipo de atención cambia según el grupo de edad.

P5. Se explora si la asociación entre la previsión y la utilización de cada tipo de atención cambia según el grupo de edad.

Finalmente, se explora si el sexo modifica estos patrones:

P6. Se explora si los patrones de utilización y su asociación con el ingreso, la previsión y el territorio difieren entre hombres y mujeres.

4 Metodología

4.1. Datos

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, observacional y transversal. Se utilizará como fuente principal de datos la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La encuesta recopila información sobre aspectos demográficos, módulos de salud, educación, vivienda, trabajo e ingresos, que permite conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social, además de evaluar el impacto de la política social (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024). La base de microdatos y su documentación metodológica son de acceso público a través del Observatorio Social del MDSF.

La población objetivo de la encuesta corresponde a las personas que residen en viviendas particulares ocupadas del territorio nacional. Quedan excluidas las personas que residen en viviendas colectivas, como establecimientos de larga estadía para personas mayores u hospitales, y las áreas clasificadas como especiales por el INE en el Marco Muestral de Viviendas (MMV) 2021, entre ellas diez comunas completas (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024, p. 29).

El diseño muestral es probabilístico, estratificado y bietápico. Los estratos se definieron por la combinación de comuna, área y nivel socioeconómico de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM); en cada estrato, la selección de UPM se realizó de forma independiente, y la unidad final de selección es la vivienda (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024). La recolección de datos se realizó entre el 1 de noviembre de 2024 y el 2 de febrero de 2025, mediante entrevistas presenciales asistidas por dispositivos electrónicos a una persona informante integrante del hogar de 18 años o más, que cuenta con la información necesaria para completar la encuesta, quien responde la totalidad de los módulos del cuestionario en representación de todos los integrantes del hogar, conforme a los criterios establecidos en el manual de campo (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024, pp. 14, 56). La muestra lograda alcanzó 218.367

personas, pertenecientes a 78.654 hogares, con una tasa de respuesta de 74,1 % (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024).

Para esta investigación, la unidad de análisis son las personas. El estudio se realiza en dos etapas: primero se describen la población y la utilización según grupo de edad, ingreso, previsión y territorio mediante porcentajes ponderados, y luego se estiman modelos multivariados. Ambas etapas se restringen a la población de 18 años y más (N = 172.309), porque la utilización de los menores de 18 años depende principalmente de las decisiones y los recursos de las personas adultas del hogar.

Todas las estimaciones estadísticas se realizarán aplicando los factores de expansión poblacional (expr) y las variables de estratos (varstrat) y conglomerados (varunit), considerando el diseño muestral complejo de la CASEN, para garantizar que los resultados sean representativos a nivel nacional. Las restricciones de la muestra se realizarán mediante estimación de subpoblaciones, y no eliminando casos, para estimar correctamente la varianza. Las respuestas "no sabe" y "no responde" se tratarán como datos perdidos. Para que los modelos anidados sean comparables, todos se estimarán sobre la misma muestra analítica: las personas con información completa en todas las variables del modelo más completo.

4.2. Variables

4.2.1. Variables dependientes

Para esta investigación, las variables dependientes corresponden a tres indicadores de utilización declarada de servicios de salud, construidos como variables dicotómicas (1 = utilizó el servicio en el período de referencia; 0 = no lo utilizó): (a) atención de medicina general en los últimos tres meses (s20a_preg); (b) atención de especialidad en los últimos tres meses (s23a_preg); y (c) hospitalización o intervención quirúrgica en los últimos doce meses (s27a). Estos indicadores miden utilización efectivamente declarada, y no permiten evaluar la oportunidad, la pertinencia ni la calidad de la atención. Dado que los períodos de referencia difieren entre servicios, la comparación entre ellos se realiza sobre patrones y no sobre niveles de utilización.

4.2.2. Variables independientes

Las variables independientes se organizarán de acuerdo con las dimensiones del Modelo Conductual de Utilización de los Servicios de Salud de Andersen (1995, 2008), distinguiendo entre factores predisponentes, facilitadores y de necesidad.

Los factores predisponentes corresponden a características sociodemográficas que anteceden a la utilización y pueden influir en la propensión a buscar atención. Se considerarán la edad, el sexo y el nivel educacional (educc). La edad se agrupa en cinco tramos 18-34, 35-49, 50-64 y 65-79 y 80+. Aunque la Ley N° 19.828 define como adulta mayor a la persona de 60 años y más, se utiliza el umbral de 65 años para mantener la comparabilidad con las cifras del INE citadas en la introducción, y el de 80 años corresponde a la cuarta edad que define la misma ley. El sexo se operacionaliza como una variable categórica nominal dicotómica, codificada como 1 = hombre y 2 = mujer. Siguiendo a Andersen (1995, 2008), la educación se trata como una característica de la estructura social y no como un recurso material. Se operacionaliza como categórica ordinal y se agrupa en cuatro categorías: básica incompleta o menos (códigos 0 y 1), básica completa o media incompleta (códigos 2 y 3), media completa (código 4) y educación superior (códigos 5 y 6). Los valores negativos, incluido el código −88 correspondiente a "no sabe" y se consideran como valores perdidos.

Los factores de necesidad corresponden a condiciones de salud que pueden generar requerimientos de atención. Se consideran dos indicadores de necesidad percibida, y no evaluada por criterios profesionales (1995, 2008): haber tenido un problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos tres meses (s16), cuyo período coincide con el de la atención de medicina general y de especialidad, y la limitación funcional, construida a partir de seis dominios (h7a a h7f): se considera que hay limitación si la persona declara mucha dificultad o imposibilidad en al menos uno de ellos, según el criterio Washington Group dado en la misma encuesta. Hay que considerar que ambos indicadores son declarados por el informante del hogar y no equivalen a una evaluación clínica.

Los factores facilitadores individuales comprenden los recursos materiales y financieros que pueden favorecer o dificultar la utilización de los servicios. Se incluirán el sistema previsional de salud (s13), agrupado en Fonasa e Isapre, y el quintil de ingreso total per cápita del hogar (ypchtotcor). Las personas con otro sistema previsional (FF.AA. y del Orden, ninguno u otro) quedan fuera del análisis, y los tramos de Fonasa (A–D) no se desagregan porque se definen por ingreso, que ya se incluye en el modelo. Se utiliza el ingreso per cápita porque permite comparar hogares de distinto tamaño y porque el gasto en salud se resuelve en gran medida en el hogar, y no solo con ingresos individuales, que no reflejan los recursos de quienes no perciben ingresos propios. Además,se emplea el ingreso total, que incluye las transferencias monetarias del Estado, y no el autónomo, por ser relevantes para la población mayor. Se agrupa en quintiles, calculados con el factor de expansión sobre la población total, porque describen la posición relativa, permiten capturar relaciones no lineales y reducen el efecto de los valores extremos.

Los factores facilitadores territoriales incorporan las barreras espaciales y de disponibilidad de recursos. Se incluirán la región de residencia como una variable categórica nominal que identifica las distintas

regiones del país el área geográfica (urbano/rural) operacionalizada como una variable categórica nominal dicotómica, codificada como 1 = urbano y 2 = rural, y la proximidad declarada de la vivienda a un centro de salud (v35c) que identifica si la vivienda se encuentra a menos de 20 cuadras o 2,5 km de un centro de salud de atención primaria o de nivel superior, con valores 1=sí y 2= no. Hay que considerar que esta variable constituye una aproximación a la cercanía territorial de los servicios y no una medida directa del acceso efectivo.

4.2.3. Valores perdidos

Los porcentajes de valores perdidos se calcularon sobre los 172.309 adultos de la muestra, sin ponderar. Son de 0,0 % en el área de residencia; 0,1 % en el quintil de ingreso y en la limitación funcional; 0,2 % en la cercanía a un centro de salud, en la atención de medicina general y en la de especialidad; 0,3 % en el nivel educacional; y 0,7 % en el problema de salud reciente. La edad, el sexo y la región no presentan valores perdidos.

La previsión y la hospitalización tienen porcentajes mayores. En la previsión, el 4,4 % de los adultos queda fuera del análisis: el 4,0 % tiene otra previsión, que se excluye por decisión metodológica, y el 0,4 % no tiene dato. En la hospitalización, el 1,0 % queda fuera: el 0,8 % corresponde a hospitalizaciones por embarazo, parto o cesárea, que se excluyen por corresponder a una lógica distinta a la de necesidad asociada a la edad, y el 0,2 % no tiene dato.

4.3. Estrategia de análisis

Se utilizarán modelos de regresión logística binaria para estimar la probabilidad de utilización de cada uno de los tres tipos de servicios de salud (medicina general, atención de especialidad y hospitalización o intervención quirúrgica) en la población de 18 años y más. Todas las estimaciones incorporan los factores de expansión y el diseño muestral de CASEN 2024. Se estimará un conjunto de modelos anidados y secuenciales para cada resultado:

- **Modelo 1: factores predisponentes.** Incorpora edad, sexo y nivel educacional.
- **Modelo 2: factores de necesidad.** Agrega el problema de salud reciente y la limitación funcional.
- **Modelo 3: factores facilitadores.** Agrega el ingreso y la previsión de salud (H1 y H2; objetivo 2) y el área de residencia y la cercanía a un centro de salud (H3; objetivo 3). La región de residencia

se incluye como variable de control. Con los resultados de este modelo para medicina general y hospitalización se exploran además P1 y P2 (objetivos 2 y 3).

- **Modelo 4: interacciones.** Para cada servicio, agrega por separado las interacciones entre el grupo de edad y el ingreso (P3), el territorio (área de residencia y cercanía a un centro de salud) (P4) y la previsión de salud (P5) (objetivo 4), y entre el sexo y estos factores (P6) (objetivo 5). Cada interacción se estima en un modelo separado.

Previo a la estimación, se evaluará la multicolinealidad entre nivel educacional, ingreso y previsión de salud mediante el factor de inflación de la varianza (VIF).

5 Resultados descriptivos

Tabla 1. Caracterización de la población de 18 años y más (%)

La Tabla 1 presenta las características de la población de 18 años y más según los factores predisponentes, facilitadores y de necesidad. En términos de la estructura etaria, el 31,7 % de la población adulta tiene entre 18 y 34 años y el 27,8 % entre 35 y 49 años, mientras que las personas de 65 años y más representan el 17,9 %, de las cuales el 4,1 % tiene 80 años o más. En la distribución por sexo, los hombres representan un 48,9 % y las mujeres un 51,1 %. El nivel educacional se distribuye principalmente en educación superior con un 41,7 %, seguida de un 31 % con educación media completa frente a valores inferiores de educación básica completa o media incompleta con 17,4 % y básica incompleta o menos con un 9,9 %.

Respecto de la necesidad, el 19,1 % declara haber tenido un problema de salud en los últimos tres meses y el 11,5 % presenta limitación funcional. En cuanto a los factores facilitadores, Fonasa concentra la mayoría de los casos con un 86,1 % frente a un 13,9 % en Isapres. En cuanto al territorio, el 88,5 % reside en zonas urbanas y el 81,8 % declara contar con un centro de salud cercano a su vivienda. Por último, la distribución por quintiles de ingreso varía desde un 16,3 % en el quintil de menores ingresos (Q1) hasta un 22 % en los quintiles Q4 y Q5. Esto se debe a que los quintiles se calcularon sobre la población total y a que los menores de 18 años se concentran en los quintiles de menores ingresos, en parte porque el ingreso per cápita es menor en los hogares con más integrantes.

\begin{table}[!h] \caption{Tabla 1. Caracterización de la población de 18 años y más (%)}

\end{table}

Variable	**Categoría**	**%**
Grupo de edad	18-34	31,7
	35-49	27,8
	50-64	22,6
	65-79	13,8
	80+	4,1
Sexo	Hombre	48,9
	Mujer	51,1
Nivel educacional	Básica incompleta o menos	9,9
	Básica completa o media incompleta	17,4
	Media completa	31,0
	Superior	41,7
Problema de salud reciente	Sí	19,1
	No	80,9
Limitación funcional	Sí	11,5
	No	88,5
Previsión de salud	FONASA	86,1
	Isapre	13,9
Quintil de ingreso	Q1	16,3
	Q2	18,8
	Q3	20,9
	Q4	22,0
	Q5	22,0
Área de residencia	Urbano	88,5
	Rural	11,5
Centro de salud a menos de 20 cuadras o 2,5 km	Sí	81,8
	No	18,2

Nota. Elaboración propia con datos de CASEN 2024.

Tabla 2. Necesidad de salud y utilización de servicios según grupo de edad (%)

La Tabla 2 muestra la distribución de los dos indicadores de necesidad y los tres tipos de utilización de los servicios de salud según los grupos etarios. Ambos indicadores de necesidad presentan un incremento progresivo a medida que aumenta la edad. El aumento más notorio se evidencia en las limitaciones funcionales, cuya prevalencia aumenta de 3,8 % en el grupo 18-34 a 54,2 % en las personas de 80 años y más. La utilización de servicios también aumenta con la edad: en este último grupo, el 44,7 % utilizó medicina general, el 31,9 % especialidad y el 14,7 % se hospitalizó. Con todo, el aumento

de la utilización es más moderado que el de la limitación funcional: la medicina general más que se duplica (19,0 % a 44,7 %), la especialidad se duplica aproximadamente (16,1 % a 31,9 %) y la hospitalización se triplica (4,7 % a 14,7 %), mientras que la limitación funcional se multiplica por más de catorce. Además, en las edades más altas el aumento de la utilización se hace más lento: entre los 65-79 años y los 80 años y más la limitación funcional se duplica (26,1 % a 54,2 %), pero la medicina general sube de 40,3 % a 44,7 % y la especialidad de 29,0 % a 31,9 %.

\begin{table}[!h] \caption{Tabla 2. Necesidad de salud y utilización de servicios según grupo de edad (%)}

Grupo de edad	Problema reciente	Limitación funcional	Medicina general	Especialidad	Hospitalización
18-34	13,7	3,8	19,0	16,1	4,7
35-49	17,4	5,1	24,4	19,6	6,9
50-64	21,5	13,4	31,3	22,2	8,7
65-79	26,9	26,1	40,3	29,0	12,2
80+	31,7	54,2	44,7	31,9	14,7
Total 18 años y más	19,1	11,5	27,3	20,9	7,7

\end{table}

Nota. Elaboración propia con datos de CASEN 2024.

Tabla 3. Utilización de servicios según ingreso, previsión y territorio (%)

La Tabla 3 muestra el porcentaje de personas que utilizan cada servicio según su quintil de ingreso, su previsión de salud y su territorio de residencia. En los tres servicios la utilización aumenta con el quintil de ingreso, y el gradiente más marcado se observa en la atención de especialidad, que va de 14,3 % en el Q1 a 30,4 % en el Q5; en medicina general va de 22,0 % a 31,2 % y en hospitalización de 6,5 % a 8,9 %. Las personas afiliadas a Isapre utilizan más los tres servicios que las afiliadas a Fonasa, con la mayor diferencia en la atención de especialidad (33,7 % frente a 19,1 %). En cuanto al territorio, residir en zona rural se asocia con menor utilización en los tres servicios, especialmente en especialidad (15,8 % frente a 21,5 % en zona urbana). La cercanía a un centro de salud muestra diferencias menores: quienes no cuentan con uno cercano utilizan menos la medicina general (26,0 % frente a 27,6 %) y la especialidad (18,5 % frente a 21,4 %), sin diferencias en hospitalización (7,7 % en ambos casos). Se trata de porcentajes brutos, que no consideran las necesidades de salud ni la relación entre los propios factores, por lo que serán evaluados en los modelos multivariados.

\begin{table}[!h] \caption{Tabla 3. Utilización de servicios según ingreso, previsión y territorio (%)}

\end{table}

Variable	**Categoría**	**Medicina general**	**Especialidad**	**Hospitalización**
Quintil de ingreso	Q1	22,0	14,3	6,5
	Q2	25,4	16,8	7,1
	Q3	27,4	18,6	7,7
	Q4	28,9	21,9	7,8
	Q5	31,2	30,4	8,9
Previsión de salud	FONASA	27,1	19,1	7,4
	Isapre	30,6	33,7	9,7
Área de residencia	Urbano	27,6	21,5	7,8
	Rural	25,0	15,8	6,8
Centro de salud cercano	Sí	27,6	21,4	7,7
	No	26,0	18,5	7,7

Nota. Elaboración propia con datos de CASEN 2024.

6 Referencias bibliográficas

Aday, L. A., & Andersen, R. (1974). A framework for the study of access to medical care. *Health Services Research*, *9*(3), 208-220. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/instance/1071804/pdf/hsresearch00560-0030.pdf

Albala, C. (2020). El envejecimiento de la población chilena y los desafíos para la salud y el bienestar de las personas mayores. *Revista Médica Clínica Las Condes*, *31*(1), 7-12. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2019.12.001

Andersen, R. M. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care: Does it matter? *Journal of Health and Social Behavior*, *36*(1), 1-10. https://doi.org/10.2307/2137284

Andersen, R. M. (2008). National health surveys and the behavioral model of health services use. *Medical Care*, *46*(7), 647-653. https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e31817a835d

Asadi-Lari, M., Packham, C., & Gray, D. (2003). Need for redefining needs. *Health and Quality of Life Outcomes*, *1*, Artículo 34. https://doi.org/10.1186/1477-7525-1-34

Banco Mundial. (s. f.-a). *Camas hospitalarias (cada 1.000 personas) - Chile*. Recuperado 18 de octubre de 2026, de https://datos.bancomundial.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS?locations=CL

Banco Mundial. (s. f.-b). *Médicos (cada 1.000 personas) - Chile*. Recuperado 18 de octubre de 2026, de https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.MED.PHYS.ZS?locations=CL

Bass del Campo, C. (2025). Universalización de Atención Primaria en Chile: una política lamentablemente regresiva. *Cuadernos Médico Sociales*, *65*(1), 53-65. https://doi.org/10.56116/cms.v65.n1.2025.2209

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). *Ley de urgencia en salud* [Ley Fácil]. Recuperado 27 de octubre de 2026, de https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/ley-de-urgencia-en-salud

Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo. *Revista Latinoamericana de Población*, *5*(8), 5-31. https://doi.org/10.31406/relap2011.v5.i1.n8.1

Chackiel, J. (2000). *El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia favorable?* Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c15fd12a-15b2-4b61-91f6-4863270ae3d8/content

Chovar Vera, A., Vásquez Lavín, F., & Paraje, G. (2014). Desigualdad e inequidad en la utilización de servicios médicos según grupos etarios en Chile, 2000–2011. *Revista Panamericana de Salud Pública*, *36*(3), 171-178. https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2014.v36n3/171-178/es

Clínicas de Chile. (2025). *Dimensionamiento de la oferta de salud en Chile 2024*. Asociación de Clínicas de Chile AG. https://www.clinicasdechile.cl/wp-content/uploads/2025/12/Dimensionamiento-del-Sector-Salud-en-Chile-%E2%80%93-Cifras-a-2024.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s. f.). *Acerca de envejecimiento*. Recuperado https://www.cepal.org/es/temas/envejecimiento/acerca-envejecimiento

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026). *Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: Retos y opciones para la política pública* (LC/CRPD.6/3).

Dannefer, D. (2003). Cumulative advantage/disadvantage and the life course: Cross-fertilizing age and social science theory. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, *58*(6), S327-S337. https://doi.org/10.1093/geronb/58.6.S327

Departamento de Estadísticas e Información de Salud. (2026, mayo 5). *Defunciones y mortalidad por capítulo CIE-10 de causa básica de defunción y año* [Tablero de datos]. Ministerio de Salud de Chile. https://informesdeis.minsal.cl/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2F4013de47-a3c2-47b8-8547-075525e4f819&sectionIndex=0&sso_guest=true&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&sas-welcome=false

Equipo EUNAMed. (2025, octubre 10). *Cómo funciona el sistema de salud en Chile*. EUNAMed.com. https://eunamed.com/blog/como-funciona-el-sistema-de-salud-en-chile/

Ferraro, K. F., & Shippee, T. P. (2009). Aging and cumulative inequality: How does inequality get under the skin? *The Gerontologist*, *49*(3), 333-343. https://doi.org/10.1093/geront/gnp034

Fuenzalida, M., Crespo, F., & Lanio, I. (2023). Análisis de la cobertura geográfica de camas hospitalarias públicas en Chile. *Revista Geográfica de Chile Terra Australis*, *59*, 92-101. https://doi.org/10.23854/07199562.2023591.fuenzalida

Gattini, C. (2018). *El sistema de salud en Chile*. Observatorio Chileno de Salud Pública, Universidad de Chile. https://www.ochisap.cl/wp-content/uploads/2022/04/Sistema_Salud_Chile_Gattini_2018.pdf

Goldstein, E. (2018). *El sistema de salud en Chile y la Atención Primaria de Salud municipal: Marco para un debate sobre desmunicipalización*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26811/2/BCN_Gobernanza_salud_y_demunicip_para_reposit_final.pdf

Goldstein, E. (2024). *Reseña sobre la Ley Corta de ISAPRES de 2024 (Ley N° 21.674)*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/36273/1/BCN__Resena_Ley_Corta_Isapres_2024__final.pdf

González, C., Castillo-Laborde, C., & Matute, I. (Eds.). (2019). *Estructura y funcionamiento del sistema de salud chileno* (Serie de Salud Poblacional N.º 2). Universidad del Desarrollo. http://hdl.handle.net/11447/2895

Henríquez, J., & Velasco, C. (2015). *Las desigualdades en la atención médica en los últimos 20 años* (Propuestas de Política Pública N.° 13). Centro de Estudios Públicos.

Huaiquilaf-Jorquera, S., Riedemann Gonzalez, J. P., Castillo Mora, J. A., & Arancibia Luna, M. J. (2026). Médicos especialistas en Chile: Análisis de la situación 2024. *Revista Médica de Chile*, *154*(3). https://www.revistamedicadechile.cl/index.php/rmedica/article/view/11531

Huenchuan, S. (2011). *La protección de la salud en el marco de la dinámica demográfica y los derechos* (Serie Población y Desarrollo). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Huenchuan, S. (Ed.). (2016). *Envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina y el Caribe: conceptos, metodologías y casos prácticos*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40197-envejecimiento-institucionalidad-publica-america-latina-caribe-conceptos

Huenchuan, S. (Ed.). (2018). *Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44369/1/S1800629_es.pdf

Hugo Rojas, F., Rodríguez Canache, L., & Rodríguez León, J. (2022). *Envejecimiento en Chile: Evolución, características de las personas mayores y desafíos demográficos para la población* (Documentos de Trabajo). Instituto Nacional de Estadísticas. https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/documentos-de-trabajo/envejecimiento-en-chile-evolucion-y-caracteristicas-de-las-personas-mayores.pdf?sfvrsn=fa394551_2

Instituto Nacional de Estadísticas. (2022). *Transición demográfica y el envejecimiento de la población en Chile: Evolución, características de las personas mayores y desafíos demográficos para la población* [Presentación]. Conferencia ciudadana, Subdepartamento de Demografía. https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/conferencias/evolucion-demografica/conferencias-ciudadanas-evolucion-demografica-en-chile.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas. (2025a). *Cifras provisionales de estadísticas vitales confirman disminución de nacimientos en 2024* [Noticia]. https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/05/15/cifras-provisionales-de-estad%C3%ADsticas-vitales-confirman-disminuci%C3%B3n-de-nacimientos-en-2024

Instituto Nacional de Estadísticas. (2025b). *Primeros resultados del Censo 2024: 18.480.432 personas fueron censadas en Chile, manteniéndose la tendencia de envejecimiento de la población.*

https://censo2024.ine.gob.cl/primeros-resultados-del-censo-2024-18-480-432-personas-fueron-censadas-en-chile-manteniendose-la-tendencia-de-envejecimiento-de-la-poblacion/

Instituto Nacional de Estadísticas. (2026). *Estimaciones y proyecciones de población 1992-2070: Base 2024. Presentación de resultados*. https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/proyecciones-de-poblacion/publicaciones-y-anuarios/proyecci%C3%B3n-base-2024/estimaciones-y-proyecciones-de-poblaci%C3%B3n-1992-2070_base-2024_presentaci%C3%B3n-de-resultados.pdf

Lantz, P. M. (2001). Socioeconomic status and health care. En N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (pp. 14558-14562). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/03828-6

Levesque, J.-F., Harris, M. F., & Russell, G. (2013). Patient-centred access to health care: Conceptualising access at the interface of health systems and populations. *International Journal for Equity in Health*, *12*, Artículo 18. https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-18

Ley N° 19.828. (2002, septiembre 27). *Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=202950

Mendoza-Sassi, R., & Béria, J. U. (2001). Utilización de los servicios de salud: una revisión sistemática sobre los factores relacionados. *Cadernos de Saúde Pública*, *17*(4), 819-832. https://www.scielosp.org/article/csp/2001.v17n4/819-832/

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Informe metodológico Casen 2024*. Observatorio Social. https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2024/Informe_metodologico_casen_2024.pdf

Ministerio de Salud. (s. f.). *Funciones y objetivos*. Gobierno de Chile. Recuperado 20 de octubre de 2026, de https://www.minsal.cl/funciones-objetivos/

Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología. (2023). *Informe vigilancia enfermedades no transmisibles 2023*. https://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2025/05/INFORME_NACIONAL_VENT_CHILE.pdf

Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología. (2025). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2023-2024: Resultados* [Presentación de diapositivas]. https://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2026/07/PPT_ENCAVI_2023_24.pdf

Ministerio de Salud, & Organización Panamericana de la Salud. (2025). *Levantamiento de información de Postas de Salud Rural*. https://www.paho.org/sites/default/files/2026/09/minsal-ops-2025-levantamiento-informacion-psr-final-comprimido.pdf

Moscoso Cuaresma, J. R., Cárdenas, E., & Juárez, C. (2017). *Determinantes sociales en salud*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. https://www.researchgate.net/profile/Julio-

Ricardo-Moscoso-Cuaresma/publication/385822723_Determinantes_sociales_en_salud/links/6736a966a78ba469f0617e2a/Determinantes-sociales-en-salud.pdf

Núñez, A., & Chi, C. (2013). Equity in health care utilization in Chile. *International Journal for Equity in Health*, *12*, Artículo 58. https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-58

Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo. (2023). *Envejecer en la ruralidad: Explorando una realidad invisibilizada* (Año 5, vol. 29).

Olguín, C. (2025, octubre 20). *Niveles de atención en salud: El rol de la atención secundaria y terciaria*. ADIPA. https://adipa.cl/noticias/niveles-de-atencion-en-salud-el-rol-de-la-atencion-secundaria-y-terciaria/

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Health at a Glance 2025: Country notes—Chile*. https://www.oecd.org/es/publications/2025/11/health-at-a-glance-2025-country-notes_2f94481e/chile_b440e042.html

Paraje, G., & Vásquez, F. (2012). Health equity in an unequal country: The use of medical services in Chile. *International Journal for Equity in Health*, *11*, Artículo 81. https://doi.org/10.1186/1475-9276-11-81

Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, *19*(2), 127-140. https://doi.org/10.1097/00005650-198102000-00001

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). *Desigualdad regional en Chile: Ingresos, salud y educación en perspectiva territorial*.

Proyecto NODO. (2021). *Comunidades y entornos rurales en Chile. Análisis y perspectivas sobre población mayor*. Sistema de las Naciones Unidas en Chile.

Robledo Marín, C. A., & Orejuela Gómez, J. J. (2021). Teorías de la sociología del envejecimiento y la vejez. *Revista Guillermo de Ockham*, *18*(1), 95-102. https://doi.org/10.21500/22563202.4660

Rodriguez Santana, I., Mason, A., Gutacker, N., Kasteridis, P., Santos, R., & Rice, N. (2023). Need, demand, supply in health care: Working definitions, and their implications for defining access. *Health Economics, Policy and Law*, *18*(1), 1-13. https://doi.org/10.1017/S1744133121000293

Servicio de Salud Metropolitano Sur. (s. f.). *Rol de la red asistencial*. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Recuperado 18 de octubre de 2026, de https://ssms.gob.cl/rol-de-la-red-asistencial/

Superintendencia de Salud. (s. f.-a). *Cómo funciona el Sistema de Salud en Chile*. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Recuperado 20 de octubre de 2026, de https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/como-funciona-el-sistema-de-salud-en-chile/

Superintendencia de Salud. (s. f.-b). *Garantías Explícitas en Salud (GES)*. Gobierno de Chile. Recuperado 20 de octubre de 2026, de https://www.superdesalud.gob.cl/tax-temas-de-orientacion/garantias-explicitas-en-salud-ges-1962/

Superintendencia de Salud. (2023). *Caracterización de las especialidades médicas en Chile en 2022*. Ministerio de Salud. https://www.superdesalud.gob.cl/documentacion/666/articles-26547_recurso_1.pdf

Travassos, C., & Martins, M. (2004). Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, *20*(Supl. 2), S190-S198. https://www.scielo.br/j/csp/a/PkyrsjDrZWwzzPVJJPbbXtQ/

Turra, C. M., & Fernandes, F. (2021). *La transición demográfica: Oportunidades y desafíos en la senda hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe* (LC/TS.2020/105). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46805-la-transicion-demografica-oportunidades-desafios-la-senda-logro-objetivos

United Nations. (2020). *World population ageing 2019* (ST/ESA/SER.A/444). https://digitallibrary.un.org/record/3907988/files/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf

United Nations. (2022). *World population prospects 2022: Summary of results* (UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3). https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

Vásquez, F., Paraje, G., & Estay, M. (2013). Income-related inequality in health and health care utilization in Chile, 2000–2009. *Revista Panamericana de Salud Pública*, *33*(2), 98-106. https://doi.org/10.1590/S1020-49892013000200004

Vignolo, J., Vacarezza, M., Álvarez, C., & Sosa, A. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. *Archivos de Medicina Interna*, *33*(1), 7-11. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es&tlng=es